

网上问诊病史（2026-08-07 生成）

版本一：核心简版（约 500 字，适合大部分网上问诊平台）

男，68 岁。

主诉：胰腺癌 IV 期化疗后并发症控制中，咨询二线方案。

现病史：

2026-03 出现黄疸，3-30 协和急诊查 CA19-9 2203、TBIL 162.3。

4-03 北医三院住院，4-07 EUS-FNA 穿刺确诊胰腺中低分化腺癌（胰头）。

4-10 ERCP 置胆道塑料支架。

5-11 起中国医学科学院肿瘤医院行 AG 方案（白蛋白紫杉醇+吉西他滨）化疗，完成 3 周期（C1 5-11、C2 5-25、C3 6-08）。

6-17 肿瘤医院复查 MR、6-18 CT：胰头 4.9×3.8cm，肝多发转移，侵犯十二指肠降段+水平段+SMV，可疑侵犯 SMA。分期升至 IV 期 mPDAC。CA19-9 6-18 复查 402（较 5-9 的 255 上升）。

6-21 急性胆管炎爆发（发热 39.2℃、PCT 2.91↑↑），

6-22 北医三院胃镜示胃腔扩张+十二指肠降部狭窄（恶性侵犯），行三腔营养管置入。

6-23 转中关村医院肿瘤病区住院至今（住院 45+ 天，双轨营养 + 抗感染保肝治疗）。

7-02 北医三院置十二指肠 SEMS，同期撤营养管改口服。

8-05 清华长庚黄永辉团队行 EUS-GE 手术，术后禁食禁水中。

分子分型（4/27 NGS）：

KRAS G12D、TP53、CDKN2A、ARID1A、MTAP 均阳性/缺失；

CLDN18.2 60% 3+ 高表达；HER2 1+；MSS、pMMR、TMB 4.1 低；

Smad4 缺失、PD-L1 阴性。

近期化验（7-19 中关村）：

HGB 90、PLT 177、WBC 5.42、NEUT 3.79、

ALT 25.5、AST 23.4、TBIL 7.8、GGT 227.7、ALB 32.8、

PCT 0.700↑、D-Dimer 0.957↑（胆道塑料支架 4 个月疑似淤积）。

体重：入住前 62.4kg（BMI 19.3，较确诊时下降近 10kg）。

既往：高血压 3 级 20 年、脑出血史（2018）、脑梗死（2023）、

帕金森综合征长期用药（雷沙吉兰+金刚烷胺+甲钴胺+多巴丝肼）、

高脂血症（阿托伐他汀）、抗血小板（西洛他唑）。

无糖尿病、无肝炎、无家族肿瘤史、不吸烟不饮酒、无药食过敏。

咨询问题：

1. AG 已停 8 周（6/8→今），是否需先做 CT+MR 评估再决定是否重启？

2. 二线方案选择：Nal-IRI+5-FU（NAPOLI-3）？佐妥昔单抗（CLDN18.2 阳性）？

3. KRAS G12D / MTAP 靶向临床试验（GFH375、BMS-986504、BAY3713372 等）入组可行性？

4. 胆道塑料支架是否需要换金属支架？何时？

5. EUS-GE 术后二线治疗启动的最佳时机？

版本二：结构化完整版（约 800 字，适合病历上传字段较宽松的平台）

【基本信息】

男，68 岁。身高 180cm，体重 62.4kg（BMI 19.3，较确诊时下降近 10kg）。

【主诉】

IV 期胰腺癌化疗+内镜手术后 3 个月，营养危机与胆道支架淤积恢复中，咨询二线化疗方案+靶向/临床试验可行性。

【现病史】

- 2026-03 黄疸起病，3-30 协和急诊 CA19-9 2203、TBIL 162.3。
- 2026-04-07 北医三院 EUS-FNA 穿刺确诊胰腺中低分化腺癌（胰头 4.5cm，累及 SMV、可疑 SMA），协和+肿瘤医院+朝阳三家外科评估一致：不可直接手术，建议新辅助化疗。
- 2026-04-10 北医三院 ERCP 胆道塑料支架置入，黄疸缓解。
- 2026-05-11、5-25、6-08 中国医学科学院肿瘤医院 AG 方案 3 周期（白蛋白紫杉醇 190mg + 吉西他滨 1.6g，14 天周期）。
- 2026-06-17 MR + 6-18 CT：胰头进展至 4.9×3.8cm，肝多发转移（最大 1.2×1.0cm），侵犯十二指肠降段+水平段，分期升至 IV 期。
- 2026-06-18 CA19-9 升至 402、CA242 77.6（生化 PD）。肿瘤医院胰胃外科主任明确无手术机会。
- 2026-06-21 急性胆管炎爆发（39.2℃、PCT 2.91、ALT 632、AST 520），美罗培南 15h 有效。
- 2026-06-22 北医三院胃镜示恶性十二指肠梗阻，行三腔营养管置入。
- 2026-06-23 转中关村医院住院至今（45+ 天）：双轨营养、抗生素三联降阶梯、保肝治疗。
- 2026-07-02 北医三院置十二指肠 SEMS，撤营养管改口服。
- 2026-07-12 化验示胆道支架淤积（ALT 74↑、GGT 262↑、PCT 0.522↑），内镜科评估无法从内镜路径更换胆道塑料支架。
- 2026-08-05 清华长庚黄永辉团队 EUS-GE 手术成功，术后禁食禁水中，等待恢复经口进食。

【AG 方案疗效评估（复杂）】

- 6-13 CT：胰头 4.2×3.8cm 稳定，肝结节部分缩小
 - 6-14 MR：确认肝多发转移
 - 生化：CA242 5/9→6/23 下降 30%（52.9→37.2）
CA19-9 5/9→6/23 上升 42%（255→362，主要来自胆道支架淤积干扰）
- 临床判断为「混合应答/可能 SD-PR」，AG 方案可能仍有效，
但已停药 8 周（6/8→8/7），需影像重评估。

【分子病理（2026-04-27 NGS）】

- KRAS G12D、TP53 V274D、CDKN2A 缺失、ARID1A 移码、MTAP 9p21.3 杂合缺失、BIRC3-METTL25B 融合
- CLDN18.2 60% 3+ 高表达 ☒
- HER2 1+、Smad4 缺失、PD-L1 阴性、MSS、pMMR、TMB 4.1（低）
- BRCA1/2 阴性

【近期化验（7-19 中关村）】

血液：HGB 90、PLT 177、WBC 5.42、NEUT 3.79、LYM# 0.84

肝功: ALT 25.5、AST 23.4、TBIL 7.3、GGT 262.1、ALB 32.8
感染: PCT 0.700↑、IL-6 10.17↑
凝血: D-Dimer 0.957↑ (高凝)、FDP 7.87↑、PT-% 74↓ (VitK 吸收障碍)
心功: NT-proBNP 100.2、TnT 0.008 (安全)

【既往史】

- 高血压 3 级 20 年 (缬沙坦 80mg QD + 氨氯地平 5mg QD)
- 高血压性脑出血 8 年 (2018 年, 保守治疗)
- 陈旧性脑梗死 3 年 (2023 年)
- 帕金森综合征 (雷沙吉兰 1mg QD + 金刚烷胺 0.1g BID + 甲钴胺 0.5mg QD + 多巴丝肼 0.125g/0.5g/0.5g TID)
- 高脂血症 (阿托伐他汀 20mg QN)
- 脑卒中二级预防 (西洛他唑 50mg BID 抗血小板)
- 无糖尿病、无肝炎、无家族肿瘤史
- 不吸烟、不饮酒、无药食过敏

【咨询问题】

1. **影像评估**: AG 停药 8 周, 需先做增强 CT+MR 再决定方案吗?
2. **AG 是否重启**: EUS-GE 术后多久可重启化疗? 是否需减量?
3. **二线方案选择**:
 - NAPOLI-3 (Nal-IRI+5-FU/LV) ?
 - 佐妥昔单抗 (Zolbetuximab) + 化疗? — CLDN18.2 60% 3+ 高表达
 - 其他?
4. **KRAS G12D / MTAP 靶向试验入组**:
 - GFH375、BMS-986504、BAY3713372 等能推荐入组吗?
5. **CLDN18.2 靶向试验/CAR-T**: CT041 等有机会入组吗?
6. **胆道塑料支架**: 置入已 4 个月疑似淤积, 是否需换金属支架? 何时换?

使用建议

- **图文问诊平台 (好大夫/微医)**: 优先用**版本一 (500 字)**, 简洁清晰
- **专家医生私人邮箱/大病咨询**: 用**版本二 (800 字)**, 信息更全
- **上传时可附**: NGS 报告 PDF + 最近 CT/MR 光盘 + 7 月化验汇总

△ 匿名化处理已完成:

- 无姓名、无身份证、无地址
- 保留就诊医院用于医生判断上下文
- 保留主管医生名可选 (如需匿名可去掉)